

Recommandations cliniques par condition

Guide de pratique pour les professionnels · Clinique Neurodisk · Fondé sur les données probantes

Synthèse des conseils qu'un professionnel (physiothérapie / kinésiologie) peut donner pour chaque condition rachidienne. Ces recommandations générales s'appuient sur les guides de pratique actuels (JOSPT lombalgie 2021 et cervicalgie 2017, revues sur la sténose et le spondylolisthésis). **Elles ne remplacent pas l'évaluation clinique individuelle** : la préférence directionnelle et la tolérance se déterminent patient par patient.

⚠ Drapeaux rouges — orienter médicalement sans délai : syndrome de la queue de cheval (troubles vésico-sphinctériens, anesthésie en selle, faiblesse bilatérale), déficit neurologique progressif, douleur nocturne/inflammatoire inexpliquée, fièvre, perte de poids, antécédent de cancer, traumatisme majeur, signes de myélopathie cervicale (troubles de l'équilibre/dextérité).

Conditions

Trousse de départ (phase initiale / non spécifique)

Objectif : rassurer, garder le patient actif, contrôler la douleur, éviter le repos prolongé.

FAVORISER

- Rester actif dans les limites du confort; reprise graduée des activités
- Marche régulière, mobilité douce (bascule du bassin, chat-chameau)
- Respiration/gestion du stress, sommeil

LIMITER / ÉVITER

- Repos au lit et immobilisation prolongés
- Évitement par peur du mouvement (kinésiophobie)

Éducation : « avoir mal ≠ se blesser »; l'imagerie ne dicte pas le pronostic; le mouvement est sécuritaire; évolution habituellement favorable.

Hernie discale

Objectif : centraliser les symptômes, réduire la pression intradiscale, protéger la racine nerveuse.

FAVORISER

- Préférence directionnelle — souvent *extension* (McKenzie : sphinx, press-up) si elle centralise
- Marche, posture neutre, changements de position fréquents
- Contrôle moteur (transverse, dead bug, bird-dog), reprise graduée

LIMITER / ÉVITER

- Flexion répétée/chargée et position assise prolongée si elles *périphéralisent* la douleur
- Soulever lourd en phase aiguë

Éducation : la majorité des hernies s'améliorent sans chirurgie et se résorbent souvent; rechercher la *centralisation* (douleur qui remonte vers le dos). Surveiller un déficit moteur progressif.

Sciatique

Objectif : désensibiliser le nerf, maintenir la mobilité, réduire l'irritation.

FAVORISER

- Marche, changements de position fréquents
- Neurodynamique douce — *glissements* du sciatique (flossing)
- Préférence directionnelle; étirements doux (piriforme, fessiers)

LIMITER / ÉVITER

- Position assise prolongée
- Étirements agressifs en tension neurale; repos prolongé

Éducation : la douleur irradiée est fréquente et s'améliore généralement; le « flossing » est un va-et-vient, pas un étirement maintenu. Surveiller déficit neuro / queue de cheval.

Radiculopathie

Objectif : réduire l'irritation radiculaire, préserver la fonction, surveiller le statut neurologique.

FAVORISER

- Préférence directionnelle / centralisation; neurodynamique
- Renforcement progressif; au cervical : rétraction (chin tuck), fléchisseurs profonds, glissements neuraux du membre supérieur

LIMITER / ÉVITER

- Positions qui périphéralisent les symptômes
- Charges qui reproduisent la douleur radiculaire

Éducation : pronostic généralement favorable; la régularité prime. Surveiller faiblesse motrice progressive, aréflexie, signes de myélopathie (cervical) → orienter.

Sténose foraminale

Objectif : ouvrir le foramen, réduire la compression de la racine.

FAVORISER

- Biais en *flexion* (genou-poitrine, flexion assise)
- Marche avec pauses, vélo, neurodynamique douce, renforcement/contrôle

LIMITER / ÉVITER

- Extension et rotation soutenues du côté atteint (ferment le foramen)

Éducation : la flexion et s'asseoir soulagent; symptômes souvent positionnels; adapter la posture.

Sténose spinale (canal lombaire)

Objectif : augmenter l'espace du canal, améliorer la tolérance à la marche (claudication neurogène).

FAVORISER

- Biais en *flexion* (genou-poitrine, posture de l'enfant, vélo légèrement penché)
- Marche par intervalles, avec appui/chariot; renforcement tronc + membres inférieurs; aérobic

LIMITER / ÉVITER

- Extension lombaire prolongée (réduit le canal d'environ 67 %)
- Station debout / marche prolongée sans pause

Éducation : la flexion et la position assise soulagent; marcher penché ou avec un panier/chariot augmente la distance; progression graduée.

Arthrose cervicale

Objectif : maintenir mobilité et force, réduire la douleur, améliorer la posture.

FAVORISER

- Amplitude cervicale active (rotation, inclinaison, rétraction)
- Renforcement des fléchisseurs profonds et des stabilisateurs scapulaires; mobilité thoracique; aérobic

LIMITER / ÉVITER

- Maintien prolongé d'une posture (écran)
- Port du collier en continu (déconditionnement)

Éducation : l'arthrose est fréquente et n'équivaut pas à la douleur; le mouvement nourrit l'articulation. Surveiller radiculopathie / myélopathie cervicale.

Arthrose lombaire

Objectif : maintenir fonction et force, réduire la douleur, rester actif.

FAVORISER

- Exercice général et renforcement progressif (chaîne postérieure, fessiers, gainage)
- Aérobie / aquaforme, mobilité, marche; perte de poids si pertinent

LIMITER / ÉVITER

- Repos prolongé et évitement par peur

Éducation : « usure » ≠ fatalité; l'exercice est protecteur et antidouleur; rester actif est la meilleure stratégie.

Spondylolyse

Objectif : protéger l'isthme, stabiliser, éviter le stress en extension.

FAVORISER

- Stabilisation lombo-pelvienne (transverse, multifides, gainage en colonne neutre)
- Contrôle moteur; étirement ischio-jambiers et fléchisseurs de hanche; reprise graduée

LIMITER / ÉVITER

- Hyperextension lombaire répétée; impact précoce; charges en extension

Éducation : bon taux de retour au sport avec une gestion adéquate; chez l'athlète de sports en extension, réintroduire extension/impact tardivement et progressivement.

Spondylolisthésis

Objectif : stabiliser, contrôler le cisaillement, éviter l'extension.

FAVORISER

- Stabilisation lombo-pelvienne; biais en flexion / neutre
- Renforcement abdominal profond et fessiers; étirements ischio / fléchisseurs de hanche; charnière de hanche (dos neutre)

LIMITER / ÉVITER

- Hyperextension, mouvements de cisaillement, impact; ne pas cambrer

Éducation : la stabilisation a des effets durables sur la douleur et la fonction; favoriser la flexion. Surveiller un déficit neuro (sténose associée).

Autre

Objectif : appliquer les principes généraux et individualiser selon l'évaluation.

FAVORISER

- Rester actif, exercice gradué, éducation à la douleur, autogestion
- Préférence directionnelle si pertinente

LIMITER / ÉVITER

- Repos prolongé et immobilisation

Éducation : réévaluer et adapter au diagnostic précis; orienter en présence de drapeaux rouges.

Clinique Neurodisk — Document de référence interne. Recommandations générales fondées sur les données probantes (JOSPT lombalgie 2021 · JOSPT cervicalgie 2017 · revues sur la sténose lombaire et le spondylolisthésis · mobilisation neurale). À individualiser selon l'évaluation clinique. Ne remplace pas le jugement professionnel.